12. DAS HERZ : DIASTOLE & SYSTOLE

DAUER : 05:06 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video erforscht die wesentliche Dynamik der systolischen und diastolischen Bewegungen des Herzens, wobei der Schwerpunkt auf deren Auswirkungen auf die Körperenergie und die Emotionen liegt. Sie lernen, die vertikalen und horizontalen Ausrichtungen des Herzens zu beobachten, was entscheidende Aspekte der emotionalen Gesundheit Ihrer Patienten aufdecken kann. Die Konzepte des ventrikulären Loopings und der Interaktion mit anderen Organsystemen wie Leber und Lunge zeigen, wie das Herz einen regulierenden Druck in seiner faszialen Umgebung aufrechterhält. Praktische Techniken zur manuellen Beurteilung der Faszien und Bewegungen ermöglichen es, diese Konzepte in einem therapeutischen Rahmen anzuwenden, während auch die Verbindung zwischen Herz und Zwerchfell für eine gute rhythmische und metabolische Funktion aufgedeckt wird.

13 - DAS HERZ: DIASTOLE & SYSTOLE

Das **Herz** speichert **Energie** in einer **faszialen** Umgebung und unterstützt so seine **Elektrizität**, sowohl in seiner aufsteigenden als auch in seiner absteigenden Phase.

Es gibt eine **angeborene Prädominanz** bei manchen Menschen, die eine **systolische** oder **diastolische** Funktion zeigen können. Ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Funktionen ist normalerweise erforderlich. Das Herz wiederholt seine embryonale Bewegung ziemlich direkt.

HERZBEWEGUNGEN UND EMOTIONALE IMPLIKATIONEN

Eine spezifische Bewegung kann gefühlt werden. Zum Beispiel sind Menschen, die zu sehr auf eine **Systole**-Bewegung ausgerichtet sind, oft auf der Suche, können aber auch schnell erschöpft sein. Umgekehrt gehen andere von diesem Punkt aus und suchen ständig einen tieferen Stützpunkt.

DAS VENTRIKULÄRE LOOPING UND DIE HERZPHASEN

Das Herz führt ein charakteristisches **Looping** aus, bei dem das **ventrikuläre** System, das ursprünglich oben lag, nach unten verlagert wird, mit einem entscheidenden Stützpunkt zwischen den **Vorhöfen** und den **Ventrikeln**.

- **Während der Systole:**

* Das Herz führt einen **Aufstieg** aus.

* Es führt eine **Supinationsbewegung** aus.

* Es neigt dazu, sich zu **vertikalisieren**.

* Es führt eine **Enttorsion** durch.

In diesem Moment öffnet sich die **Aorta**, um das gesamte Blut aufzunehmen, was zu einer **Stauung** führt.

- **Während der Diastole (Abstieg):**

* Das gesamte Blut aus der Aorta wird in das System ausgeworfen.

Es ist manchmal leicht, die systolische Bewegung mit der Abwärtsbewegung zu verwechseln. Die Systole ist der Moment der **Ejektion**. Wenn das Herz wieder absinkt, **füllt es sich wieder**.

Wenn das Volumen ausgeworfen wird, steigt der Druck im System des Aortenbogens. Beim Absinken füllt sich das Herz, während es die Aorta auswirft.

HERZAUSRICHTUNG: VERTIKALISIERUNG VS. HORIZONTALISIERUNG

Haben Sie den Eindruck, dass das Herz dazu neigt, sich zu **vertikalisieren** oder zu **horizontalisieren**? Vertikalisiert es sich und steigt auf, oder horizontalisiert es sich und sinkt ab?

STÜTZPUNKTE ZUR BEOBACHTUNG

Wir werden drei Stützpunkte nehmen:

1. Auf Höhe des **Aortenraums** (zweiter Interkostalraum).

2. Auf Höhe des **Lungenraums**.

3. Die **Hypothenar-Eminenz** wird sich auf die Herzspitze legen.

DIE BEEINFLUSSENDEN SYSTEME DES HERZENS

Das Herz reagiert in Abhängigkeit von zwei großen Systemen, die ihm sehr nahe sind, und neigt dazu, diese maximal zu unterstützen:

- Die **Leber**
- Der **Magen**
- Die **Lungen**
- Die **Nieren**

Es versucht immer, diesen Druck in seiner Umgebung aufrechtzuerhalten. Das Herz ist ein **Volumenregulator**. Man muss das Herz als eine große Arterie betrachten, die sich mit der Aorta fortsetzt, wie ein **Oktopus**.

SUPINATIONS- UND PRONATIONSBEWEGUNGEN

Wir werden eine **Supinationsbewegung** und dann eine **Pronationsbewegung** haben.

MANUELLE BEURTEILUNG UND FASZIALE REAKTIVITÄT

Wir werden die Umgebung beobachten und wie sie angeordnet ist. Dann werden wir die Hände auf die Leber legen und ihre Reaktion auf einer **faszialen** Ebene beobachten.

Die Aorta, wenn man sie anatomisch genau betrachtet, entspringt tatsächlich ziemlich weit hinten, was ihre Visualisierung erschwert. Sie teilt sich jedoch eine gemeinsame fasziale Umgebung mit den **Bronchien** und der **Speiseröhre**, die sich an einem oft adaptierten Wirbel einfügen.

DIE RHYTHMISCHEN ZONEN UND DIE ZWERCHFELLBEZIEHUNG

Es gibt:

- Eine **neurosensorische** Zone.
- Eine **rhythmische** Zone.
- Eine **metabolische** Zone.
- Eine **urogenitale** Zone.

Für eine gute Bewegung muss das Herz eine gute Beziehung zum **Zwerchfell** haben. Es besteht eine direkte Beziehung über die fasziale Kontinuität des Aortenbogens und der Aorta.

Erinnern Sie sich an den sehr tiefen Durchtritt der Aorta, wo die **Zwerchfellschenkel** beidseitig ansetzen. Um das Herz zu bearbeiten, ist es entscheidend, dass das Zwerchfell **offen** und **geschmeidig** ist. Vergessen Sie nicht den anderen wichtigen Durchtritt auf Höhe der Speiseröhre.

PRAKTISCHE ANWENDUNG: VERFOLGUNG FASZIALER BEWEGUNGEN

Wir haben das **embryonale Fulcrum Pre-Pattern** studiert, das sich auf Höhe der Primitivrinne, auf Höhe des Steißbeins, mit dem Ankunftspunkt positioniert.

Legen wir nun die Hand auf das Herz und lassen sie der faszialen Bewegung folgen. Das Gewebe, wenn Sie aufmerksam sind, wird Ihnen anzeigen, ob das Herz eher zur Systole oder zur Diastole neigt.

Reagiert meine Leber? Ist es im Verhältnis zu meinem Magen? Oder ist es im Verhältnis zu meinen Nieren? (Drei Ebenen). Dann werden wir beobachten, ob sich dies im Verhältnis zu dieser Beobachtung wieder ausgleichen kann.